

Service de médecine interne
EH Didouche Mourad
Constantine

LES SYNDROMES PULMONAIRES

Dr M.S. Djebaili
Maître assistant en Médecine interne;
Service de médecine interne EH DM;
Laboratoire de recherche Diab-Suc;
Univeristé 3, Constantine.

02/02/2025

Objectifs pédagogiques

Savoir définir les termes :

syndrome de condensation non rétractile

syndrome de condensation rétractile

syndrome cavitaire

atélectasie

Différencier entre les différents syndromes

INTRODUCTION

Définition d'un syndrome: ensemble de signes cliniques et/ou paracliniques regroupant plusieurs étiologies

Les syndromes de condensation pulmonaire

La condensation pulmonaire est une densification du parenchyme pulmonaire intéressant, le plus souvent un lobe qui ressemble alors macroscopiquement à du parenchyme hépatique d'où le terme d'hépatisation.

Le parenchyme pulmonaire, siège d'une hépatisation, perd son élasticité et il ne flotte plus dans l'eau.

La condensation pulmonaire peut être d'origine

La plus fréquente est infectieuse (bactérienne ou virale) : c'est la pneumonie franche lobaire aiguë.

Soit vasculaire (une embolie artérielle) : c'est l'infarctus pulmonaire. Ces deux premiers types réalisent un syndrome de condensation pulmonaire non rétractile.

Soit à une obstruction bronchique : réalisant l'atélectasie qui est l'absence de ventilation dans le territoire pulmonaire dépendant de la bronche obstruée : réalisant un syndrome de condensation pulmonaire rétractile.

1. Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

Elles peuvent intéresser : un ou plusieurs segments, un ou plusieurs lobes, un poumon tout entier

Quel que soit le mécanisme : infection bactérienne ou vasculaire, sera reconnu sur les signes suivants :

Signes généraux:

Ils sont présents ou absents selon l'étiologie,

Signes fonctionnels:

Ils dépendent de l'étiologie, la toux étant le symptôme le plus constant.

Signes physiques

L'examen clinique doit toujours être conduit en comparant la zone pathologique aux autres zones saines et au poumon controlatéral. **palpation** : augmentation des vibrations vocales; plus ou moins patente selon l'étendue de la zone de condensation pulmonaire **percussion** : matité ou submatité à limites nettes; **auscultation** : abolition du murmure vésiculaire dans la zone de condensation parenchymateuse et présence de râles crépitant de tonalité haute survenant en fin d'inspiration profonde dus à l'exsudation alvéolaire associés secondairement à un souffle tubaire. (transmission anormale du bruit trachéo-bronchique)

Radiologiquement :

Sur le téléthorax de face, présence d'une opacité homogène plus ou moins dense, bien limitée, dont la topographie sera précisée par le cliché de profil

L'existence d'un bronchogramme aérien est un très bon élément pour confirmer l'origine parenchymateuse de cette condensation

Pneumonie franche lobaire aiguë : est reconnue

A la phase de début :

- **Sur les signes fonctionnels : douleur thoracique à type de point de côté sous mamelonnaire, toux sèche, la fièvre.**
- **Sur les signes physiques : à l'examen clinique on retrouve la triade classique du syndrome de condensation pulmonaire avec à l'auscultation des râles crépitants (fins-secs égaux entre eux, régulièrement espacés - éclatant en bouffée en fin d'inspiration) mais pas de souffle tubaire.**

A la phase d'état : à partir du troisième jour.

- **Sur les signes fonctionnels : persistance de la toux qui ramène l'expectoration caractéristique : « les crachats rouillés » de Laennec : crachats visqueux, adhérents, de couleur orangée ou ocre ,la fièvre qui persiste.**
- **Sur les signes physiques : à l'auscultation apparition d'un souffle tubaire (intense à tonalité élevée de timbre rude à prédominance inspiratoire) qui refoule les râles crépitants à la périphérie.**

L'infarctus pulmonaire

- Succède à une embolie pulmonaire
 - L'embolie pulmonaire est suspectée chez un opéré récent, une accouchée ou un sujet alité sur l'apparition brutale :
 - De signes fonctionnels : douleur thoracique à type de point de côté basi-thoracique ou parasternale avec polypnée et angoisse
 - De signes généraux : pouls rapide, élévation de la température.
 - De signes physiques : recherche de signes de phlébite des membres inférieurs : signe de Homans (douleur provoquée à la dorsi-flexion du pied).
- L'examen pleuro-pulmonaire est normal.
- persistance de la toux qui ramène une expectoration hémoptoïque caractéristique.**

2. Le syndrome de condensation pulmonaire rétractile ou atélectasie

Lorsque l'atélectasie intéresse un lobe : on retrouve les signes suivants :

- **Palpation : les vibrations vocales sont soit normales, ou augmentées, soit le plus souvent diminuées (ce qui peut s'expliquer par l'obstruction de la bronche).**
- **Percussion : matité franche.**
- **Auscultation : abolition du murmure vésiculaire.**

Lorsque l'atélectasie intéresse tout un champ pulmonaire : aux signes précédents retrouvés sur toute la hauteur de l'hémithorax s'ajoutent à l'inspection : une immobilité et une rétraction de l'hémithorax correspondant avec pincement des espaces intercostaux.

La radiographie va montrer une opacité dense, homogène systématisée et rétractée avec pincement des espaces intercostaux, attraction des organes de voisinage vers le territoire atelectasie : déplacement du médiastin, surélévation de l'hémicoupe diaphragmatique si l'atelectasié intéresse un hémithorax.

Le syndrome cavitare

Définition :

Il réalise le plus souvent un syndrome de condensation pulmonaire excavée caractéristique de la caverne tuberculeuse et de l'abcès du poumon à la phase de foyer ouvert.

Les signes physiques associant des :

Signes de condensation pulmonaire :

- **Palpation : augmentation des vibrations vocales.**
- **Percussion : matité.**
- **Auscultation : abolition du murmure vésiculaire.**

Les signes propres à l'excavation sont retrouvés à l'auscultation.

- **Le souffle cavitaire : intense, à tonalité basse, de timbre creux, à prédominance inspiratoire.**
- **Les râles consonants : sont des râles forts, humides et métalliques. L'association du souffle cavitaire et des râles consonants réalise lors de la reprise de la toux « un bruit de gargouillement » caractéristique de l'excavation de la lésion.**

Les signes radiologiques :

Le téléthorax montre une cavité circulaire aérique entourée d'une plage de condensation dense plus ou moins étendue.



L'emphysème

Définition :

c'est une dilatation anormale des cavités aériennes distales au-delà des bronchioles terminales avec lésions destructrices des alvéoles. Il réalise un syndrome de distension alvéolaire.

Il est reconnu sur les signes cliniques suivants :Dyspnée permanente de type expiratoire exagérée par l'effort

Inspection:

- Modification morphologique du thorax : réalisant le thorax en tonneau.
- Diminution de l'ampliation thoracique appréciée par la mesure de l'indice de Hirtz qui est très diminué, entre 2 à 4 cm (au lieu de 7 cm chez le sujet normal).
- Tirage intercostal.

Palpation :

- **Diminution des vibrations vocales au niveau des deux hémithorax.**
- **Diminution du choc de pointe**

Percussion :

- **Hypersonorité des deux hémithorax.**

Auscultation :

- **Diminution du murmure vésiculaire au niveau des deux hémithorax.**
- **Inversion du rythme respiratoire avec expiration prolongée.**
- **Diminution de l'intensité des bruits du cœur qui paraissent assourdis.**

La radiographie va montrer :

- **Un élargissement des espaces intercostaux et une horizontalisation des côtes.**
- **Une hyperclarté du parenchyme pulmonaire.**

L'exploration fonctionnelle respiratoire : va montrer un syndrome de type obstructif associant :

- **Une diminution de la capacité vitale par diminution du volume de réserve expiratoire.**
- **Une diminution importante du VEMS et diminution de l'indice de Tiffeneau.**
- **La mesure des gaz du sang va objectiver une hypoxie (diminution de la p O₂) avec diminution de la saturation en oxygène de l'hémoglobine et souvent une hypercapnie (augmentation de la p CO₂).**



Merci pour votre attention

Des questions??

